

1) Dans le cadre de la Loi sur l'assurance maladie, une commission de l'Office fédéral des assurances sociales discute de la prise en charge par l'assurance de base de ce que l'on nomme les "orphan drugs" (médicaments orphelins). Ils sont utilisés pour des maladies très rares et leurs coûts de développement ne peuvent être couverts par les bénéfices attendus. La partie A de la commission est de l'avis qu'il n'est pas justifiable, pour des raisons éthiques, de refuser un traitement à des patients qui peuvent en bénéficier. La partie B craint que la prise en charge d'un traitement spécifique ne crée un précédent pour d'autres cas semblables et que, de ce fait, d'autres prestations touchant davantage de personnes ne puissent plus être financées. Jugez du bien-fondé des affirmations suivantes:

- (A) La partie A de la commission considère l'aspect microéthique/personnel de la question.
- (B) La partie B de la commission s'inquiète des incidences macroéconomiques.
- (C) Cette discussion n'est pas pertinente car dans le cadre de la Loi sur l'assurance maladie, il est dit que les assurances maladies doivent prendre en charge tout traitement efficace.
- (D) En Suisse, chaque médecin est libre de prescrire les médicaments qu'il juge efficaces.

2) Un médecin-assistant se demande s'il peut interrompre la ventilation d'un patient incurable et inconscient. Il craint l'avocat de la famille. Qu'est-ce qui s'applique à cette situation?

(A) Les directives sur l'assistance au décès édictées par l'Académie suisse des sciences médicales le protègent de toute poursuite judiciaire.

(B) La volonté du patient doit toujours être respectée obligatoire.

(C) En Suisse, les proches ne peuvent s'immiscer dans ces situations.

(D) Avant de s'adresser à la famille, le médecin-assistant doit s'assurer que les organes peuvent être transplantés.

(E) Aucune de ces réponses n'est correcte

3) Un pédiatre reçoit un couple de parents qui refusent la vaccination Di-Te-Per pour leurs deux enfants.
De quel(s) élément(s) le pédiatre doit-il tenir compte dans sa discussion avec les parents?

- (A) le droit des enfants à une prise en charge médicale optimale
- (B) les croyances et représentations de la santé des parents.
- (C) les coûts de la santé liés à la vaccination / non vaccination
- (D) l'immunité de la communauté par rapport aux maladies en question

4) Une patiente en état général légèrement réduit, vous est adressée par son médecin traitant pour le traitement d'une sinusite maxillaire chronique. Elle a déjà reçu des antibiotiques à trois reprises sans succès. La patiente se plaint que d'un écoulement nasal indolore du côté gauche. A l'examen des images du CT qu'elle vous a apportées, vous constatez que le sinus maxillaire gauche est voilé sur toute sa surface. A l'endoscopie, vous observez un écoulement purulent au niveau du méat moyen. Pour vous, l'indication opératoire est posée et vous en discutez avec la patiente, qui refuse toutefois catégoriquement l'intervention.

Quelle mesure n'est pas indiquée dans ce cas?

- | |
|--|
| (A) Rediscuter avec le médecin traitant |
| (B) Proposer un conseilium psychiatrique, car la patiente n'a apparemment pas conscience de la maladie dont elle souffre |
| (C) Informer la patiente des complications possibles d'une sinusite. |
| (D) Prescrire une nouvelle cure d'antibiotiques d'une durée de 2 semaines, accompagnée d'un traitement décongestionnant |
| (E) Fixer un rendez-vous de contrôle avec un proche |

5) Un adolescent de 17 ans est admis aux urgences pour une appendicite aiguë dont le diagnostic clinique ne fait aucun doute. Son état somatique est stable et il est légèrement fébrile. Mis à part une légère irritabilité et des faibles troubles de la concentration, le status psychopathologique ne révèle rien de particulier. Pour ce qui est du consentement à l'opération, ce patient est considéré comme

(A) majeur

(B) capable de discernement

(C) capable d'exercer ses droits civiques

(D) capable de disposer par testament

(E) responsable de ses actes

6) Une femme de 66 ans atteinte d'un carcinome mammaire métastasé depuis plusieurs années est hospitalisée en raison de l'apparition récente d'une carcinose péritonéale. Depuis quelques jours, sa tension artérielle est très basse et elle souffre d'une défaillance rénale aiguë. Vu son état général et le niveau bas de sa tension artérielle, les néphrologues ne voient aucune possibilité de la dialyser. Ses proches insistent pour qu'elle soit soumise à une dialyse, à défaut de quoi ils engageront des démarches juridiques. La patiente se rallie à leur exigence. Quelle est la manière la plus appropriée d'apprécier la situation?

- (A) Tout patient a le droit d'être traité par dialyse quel que soit son état.
- (B) La volonté du patient de subir une dialyse l'emporte sur l'appréciation des médecins. Il convient donc de pratiquer une dialyse.
- (C) Vu que les proches sont aussi favorables au traitement par dialyse et qu'ils menacent d'engager des démarches juridiques, ce dernier doit être effectué.
- (D) Le fait que d'un point de vue médical, le traitement par dialyse ne soit pas indiqué l'emporte sur le souhait des proches et de la patiente.
- (E) En pareille situation, il y a lieu de faire appel à des autorités juridiques (autorité de protection de l'adulte, procureur).

7) Après avoir été réanimé, un homme de 78 ans est conduit à l'hôpital universitaire avec une suspicion de choc cardiogène dû à un grave infarctus du myocarde. Il est inconscient. Dans son portefeuille, le médecin d'urgence a trouvé un document indiquant que le patient a rédigé des directives anticipées qui sont déposées chez son médecin traitant. En attendant d'en prendre connaissance, l'équipe médicale prépare le patient pour lui poser un ballon intra-aortique destiné à soutenir provisoirement sa fonction cardiaque. La lecture des directives anticipées révèle que le patient, toujours inconscient, s'oppose à toute mesure de prolongation de la vie en cas de séquelles prévisibles et précise qu'il ne souhaite pas être placé sous assistance respiratoire. Arrivés immédiatement après lui, ses proches – dont sa fille enceinte de neuf mois – sont surpris et bouleversés par la teneur des directives anticipées. Selon eux, le patient se réjouit tellement de la naissance de son premier petit-fils que, malgré les risques de séquelles, il opérerait vraisemblablement, maintenant, pour une thérapie maximale. Compte tenu du diagnostic, des séquelles probables et des possibilités de traitement, les mesures salvatrices doivent être

- (A) interrompues pour respecter la volonté que le patient a clairement exprimée dans ses directives anticipées
- (B) interrompues pour concorder avec l'appréciation médicale
- (C) poursuivies dans un premier temps pour respecter la volonté que le patient a exprimée dans ses directives anticipées, et ce indépendamment des déclarations de ses proches
- (D) poursuivies dans un premier temps, pendant lequel la volonté présumée du patient est discutée avec ses proches
- (E) poursuivies dans un premier temps, tout en respectant au mieux l'intérêt objectif du patient